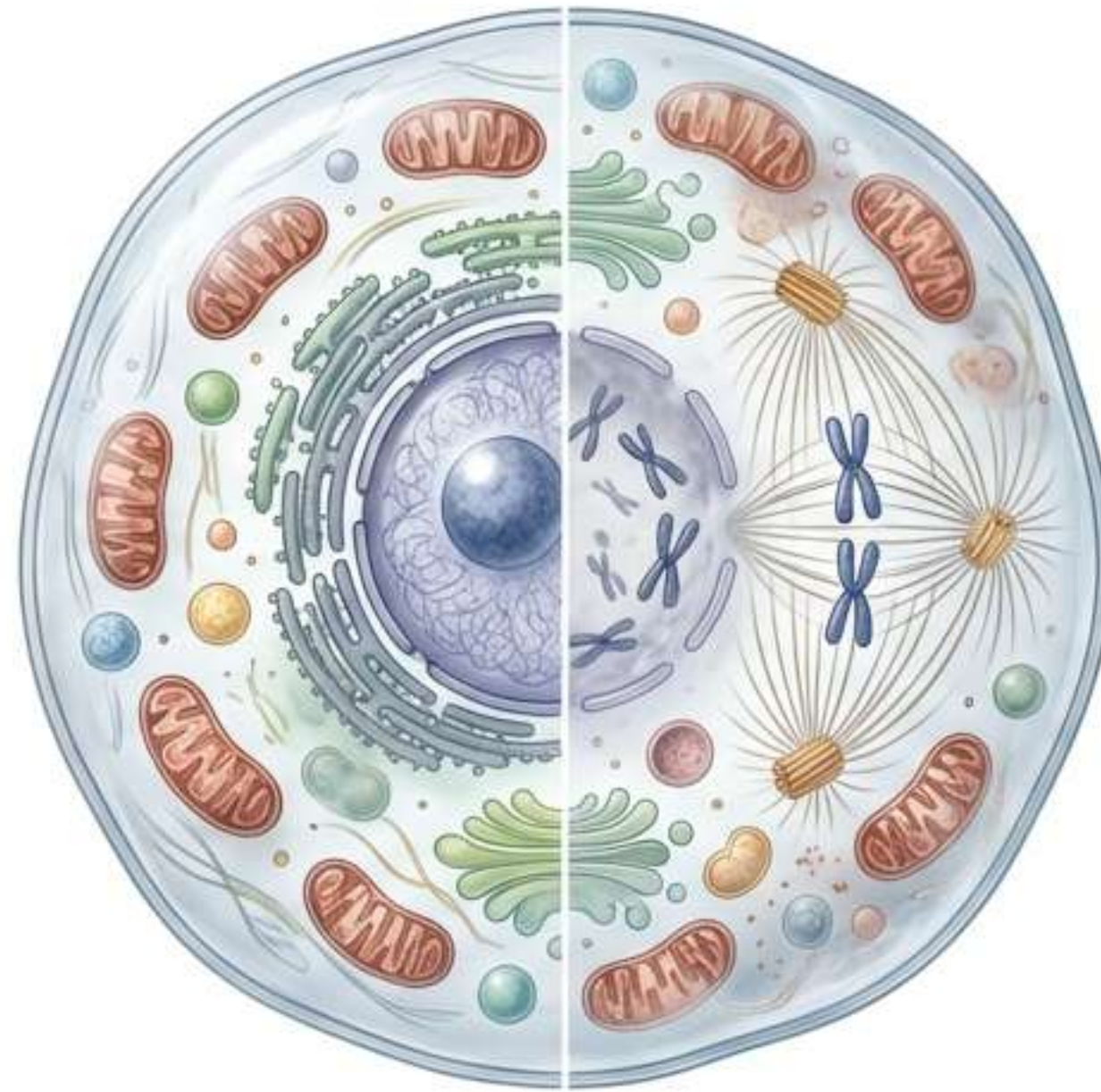


GÉNÉRALITÉS SUR LES TUMEURS

Guide d'Étude & Préparation aux Examens



Pathologie Générale - Définitions et Classifications

Plan du Cours

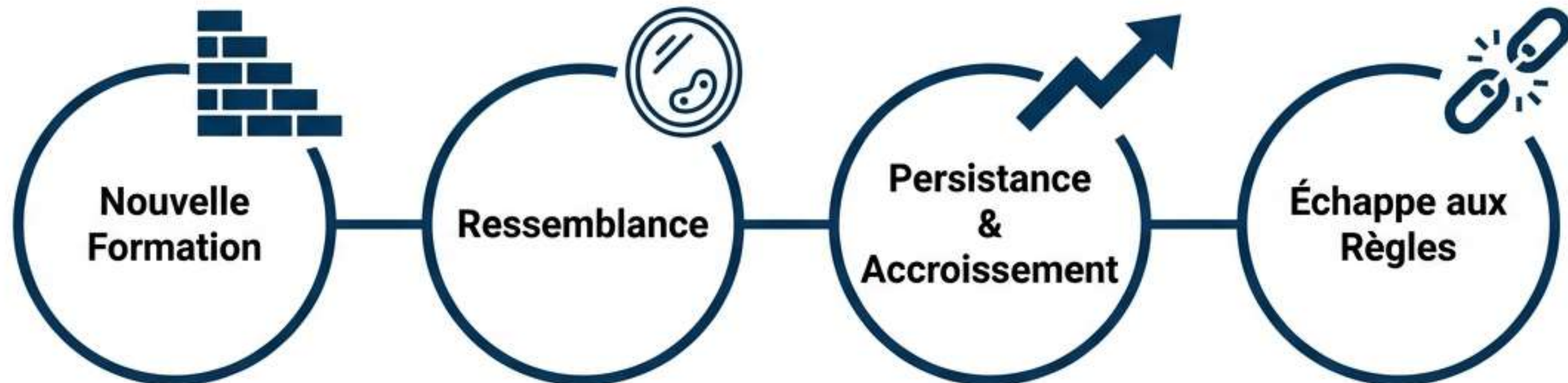
- 1 ● 🔍 Définition et Caractères Généraux
- 2 ● ≠ Les Pseudo-tumeurs (Diagnostic différentiel)
- 3 ● ⚖ Classification des Tumeurs (Critères de Malignité)
 - Clonalité
 - Différenciation
 - Taux de croissance
 - Envahissement local
 - Métastases
- 4 ● 📋 Synthèse : Tumeurs Bénignes vs Malignes
- 5 ● 🏷 Nomenclature (Épithélial, Conjonctif, etc.)

A. Définition de la Tumeur

Évolution du terme : Anciennement, '**tumeur**' désignait toute **augmentation de volume** (tuméfaction). Actuellement, le terme est synonyme de néoplasme ou néoplasie.

La Définition de Willis : Une tumeur est une **nouvelle formation tissulaire** (plus ou moins volumineuse) ressemblant (plus ou moins) au **tissu normal homologue** (adulte ou embryonnaire) aux dépens duquel elle s'est développée...

Une tumeur est définie comme une nouvelle formation tissulaire, qui a tendance à **persister et à s'accroître**, qui **échappe aux règles biologiques de la croissance**, et qui **ressemble au tissu normal homologue**. [Ref: Q1]



Les 4 Caractères Fondamentaux



1. **Prolifération** : Qualitativement et quantitativement anormale des éléments cellulaires d'un tissu organisé.

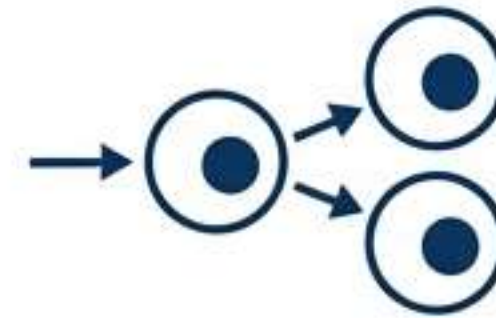


2. **Accroissement** : Excessif et incoordonné par rapport aux tissus voisins.

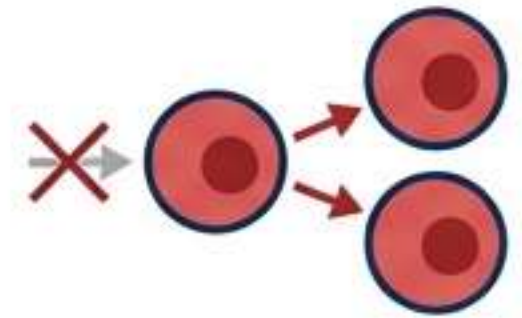


3. **Autonomie** : La prolifération tumorale se poursuit après arrêt du 'stimulus' qui lui a donné naissance. [Ref: Q1]

Stimulus ON



Stimulus OFF



4. **Indépendance Biologique** : Elle échappe à tout contrôle de l'organisme.

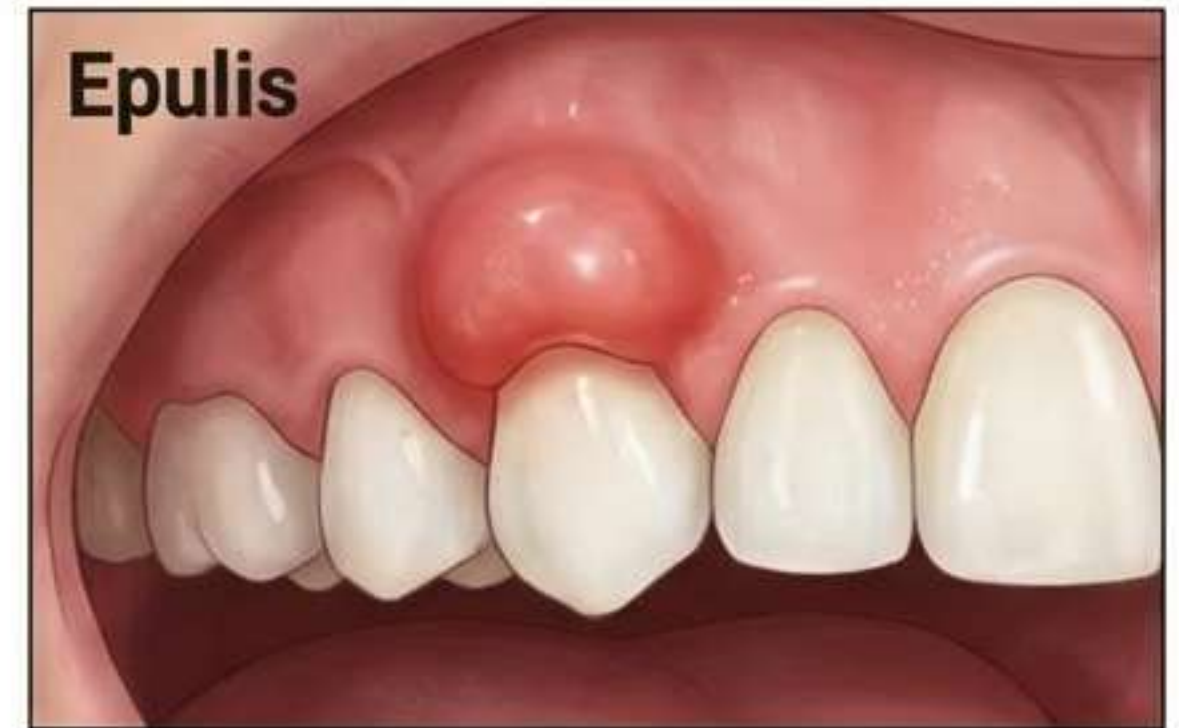
1. Les Pseudo-tumeurs (1/3) : Inflammatoires

Définition :

Lésions confondues avec des néoplasmes mais qu'il faut distinguer. Ce sont des augmentations locales de volume dues à une réaction inflammatoire (subaiguë ou chronique).

Exemples Clés :

- Bourgeon charnu hyperplasique : Botryomycome cutané, Epulis gingivale.
- Réaction à corps étranger.
- Cicatrice hypertrophique : Chéloïde.



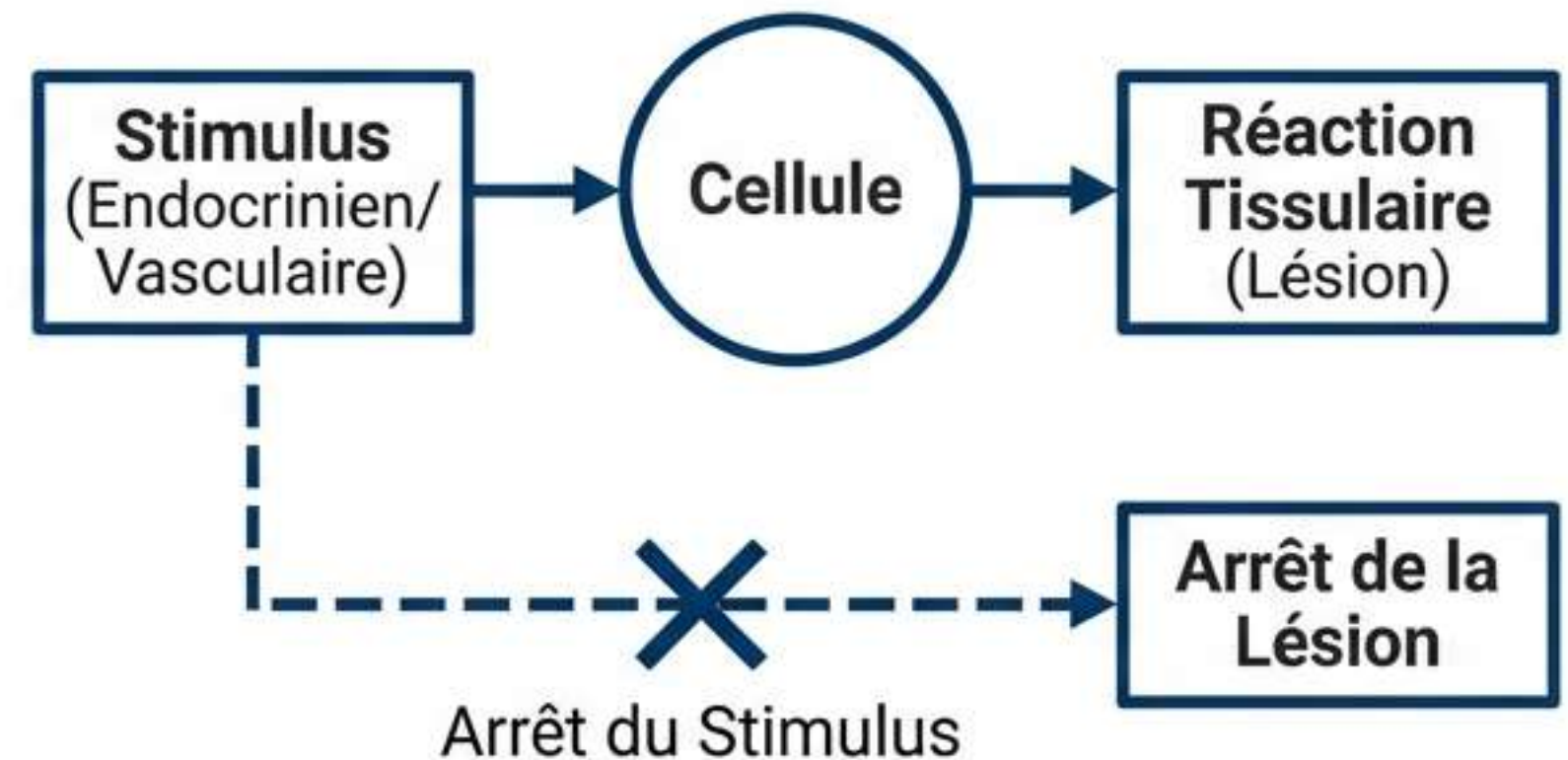
1. Les Pseudo-tumeurs (2/3) : Dystrophiques & Malformatives

Pseudo-tumeurs Dystrophiques

- **Définition** : Lésion secondaire à un trouble nutritionnel, endocrinien, ou vasculaire retentissant sur la trophicité cellulaire.
- **Cause** : En relation directe avec des stimuli.

Pseudo-tumeurs Malformatives

- Définition : Lésions secondaires à un trouble de l'organogenèse.



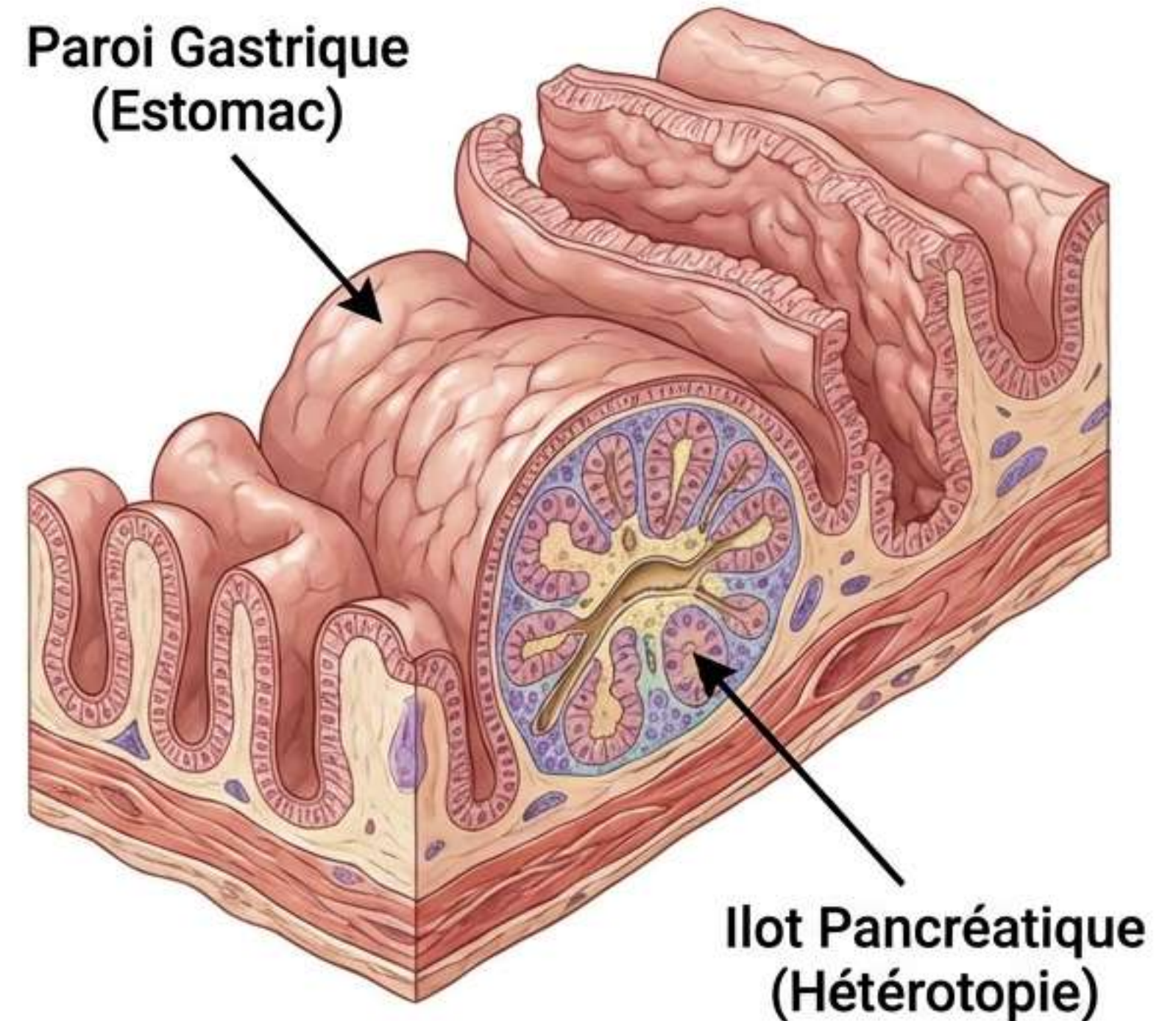
1. Les Pseudo-tumeurs (3/3) : Le Choristome

Grec *choristos* (séparé) + *-ome* (tumeur).

HÉTÉROTOPIE

- Présence de cellules ou d'un tissu d'aspect microscopique normal.
- Normalement ABSENTS dans la localisation considérée.

Le choristome est une pseudo-tumeur définie comme la présence d'un tissu normal dans un organe où il n'existe pas normalement (hétérotopie). [Ref: Q10]



1. Les Pseudo-tumeurs (Fin) : L'Hamartome & Reliquats

Section A: L'Hamartome (Dysembryoplasie)

Etymology : Grec hamartenien (manquer le but).

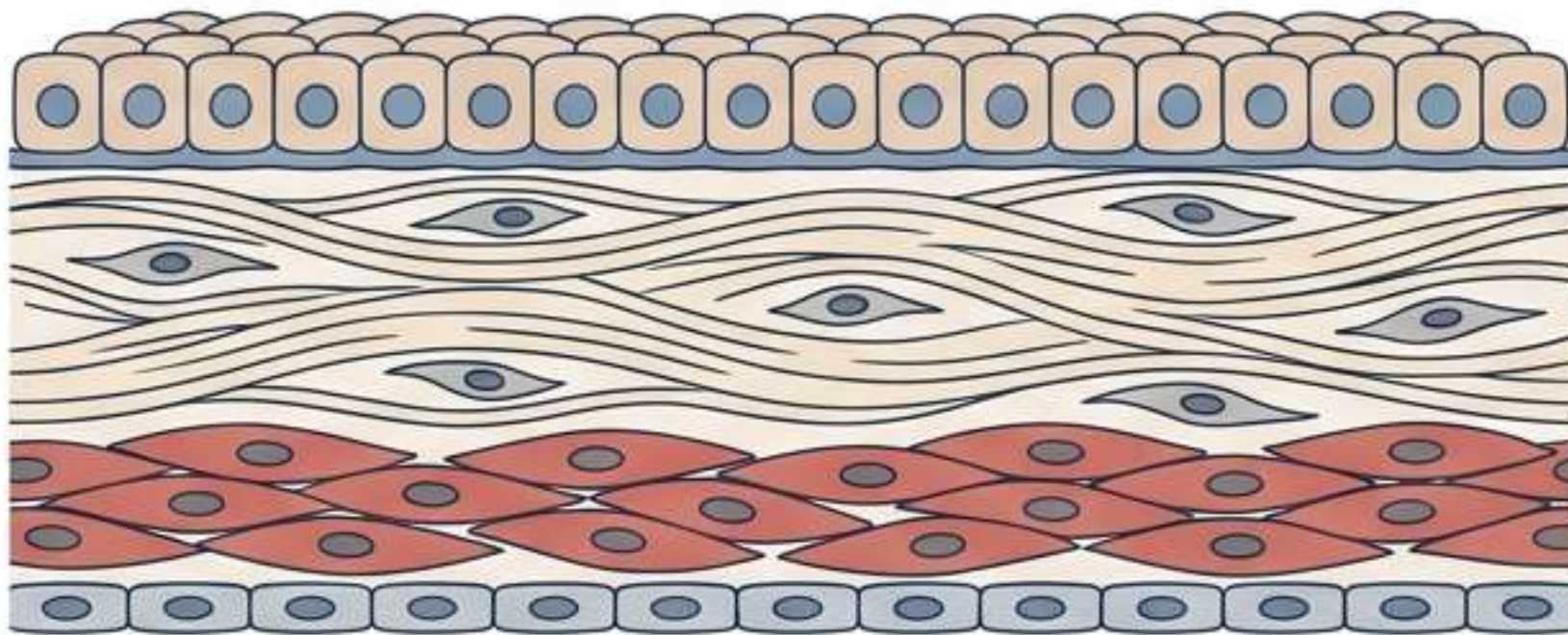
Définition : Cellules/tissus d'aspect microscopique normal, normalement PRÉSENTS dans l'organe.

Anomalie : Quantité excessive ou disposition anormale (architecture désorganisée).

Note : Ce n'est PAS une hétérotopie.

L'hamartome est une pseudo-tumeur formée d'un mélange désordonné de tissus normalement présents dans l'organe. [Ref: Q6]

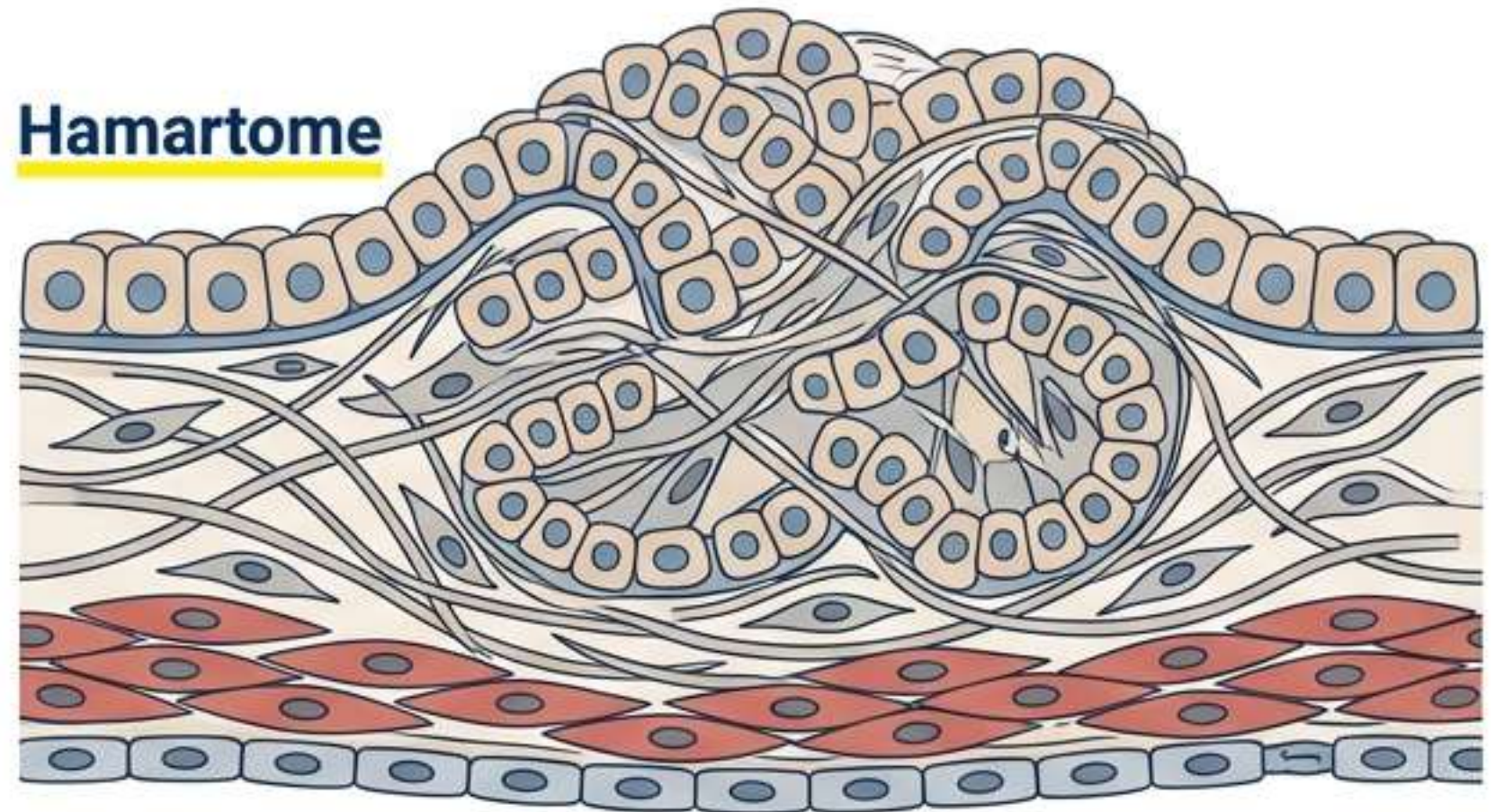
Tissu Normal



Section B: Reliquats Embryonnaires

Persistance d'une structure embryonnaire qui aurait dû disparaître.

Hamartome



2. Classification : Critère 1 - La Clonalité

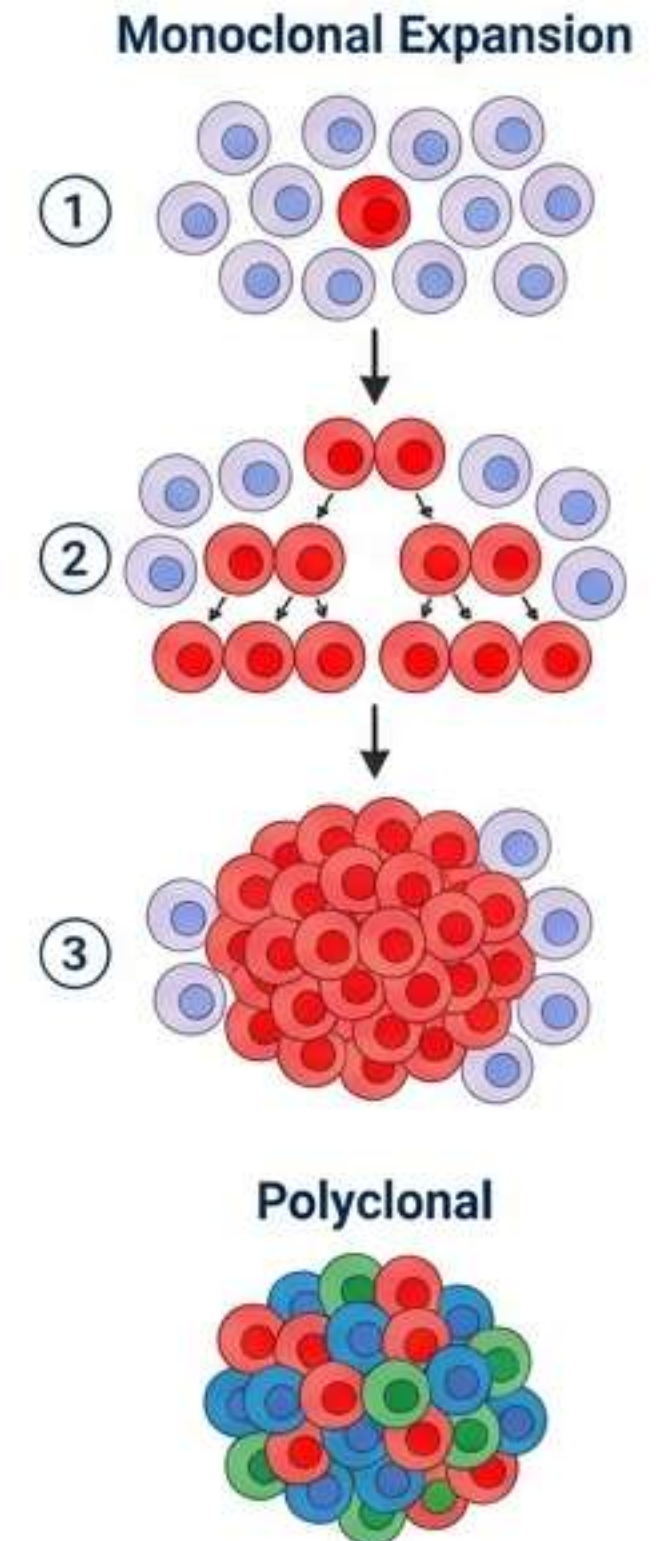
Polyclonal : Tumeur issue d'un groupe de cellules.

Oligoclonal : Tumeur issue de quelques cellules.

Monoclonal : Tumeur issue d'une SEULE cellule initiale.

Règle : Les tumeurs **maligènes** sont **monoclonales** (la prolifération correspond à un **même clone cellulaire**).

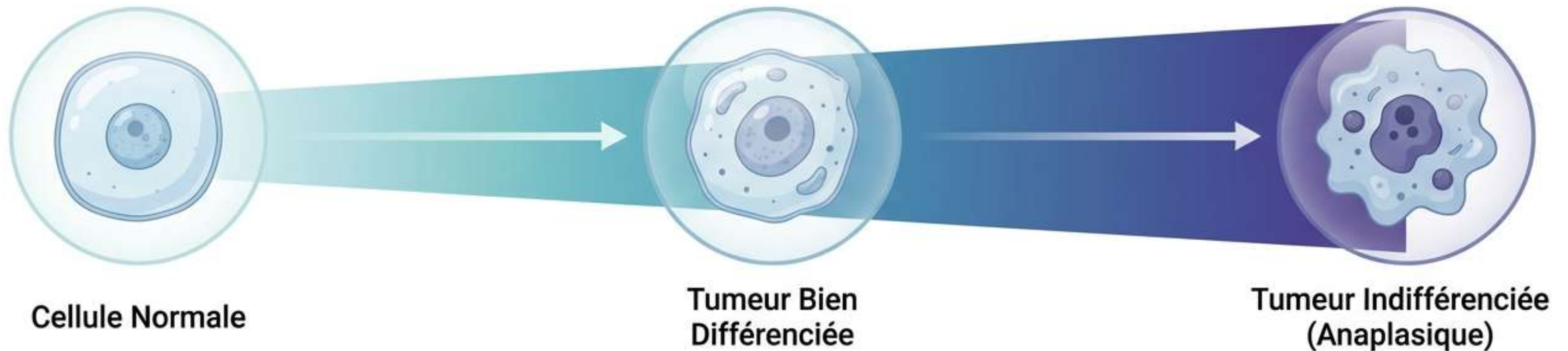
Détection : Southern blot, PCR (remaniement gène lymphoïde), Inactivation chromosome X.



2. Classification : Critère 2 - La Différenciation (Concepts)

Définition : Traduit le degré de ressemblance (morphologique et fonctionnelle) entre les cellules néoplasiques et les cellules normales d'origine.

- **Tumeurs Bénignes** : Toujours bien différenciées (ex: Léiomyome ressemble au muscle lisse).
- **Tumeurs Malignes** : Variable (Bien différenciées, peu différenciées ou indifférenciées).



Important : L'absence de différenciation ne signifie pas dédifférenciation.

2. Classification : Critère 2 - Anaplasie & Maturation

L'Anaplasie

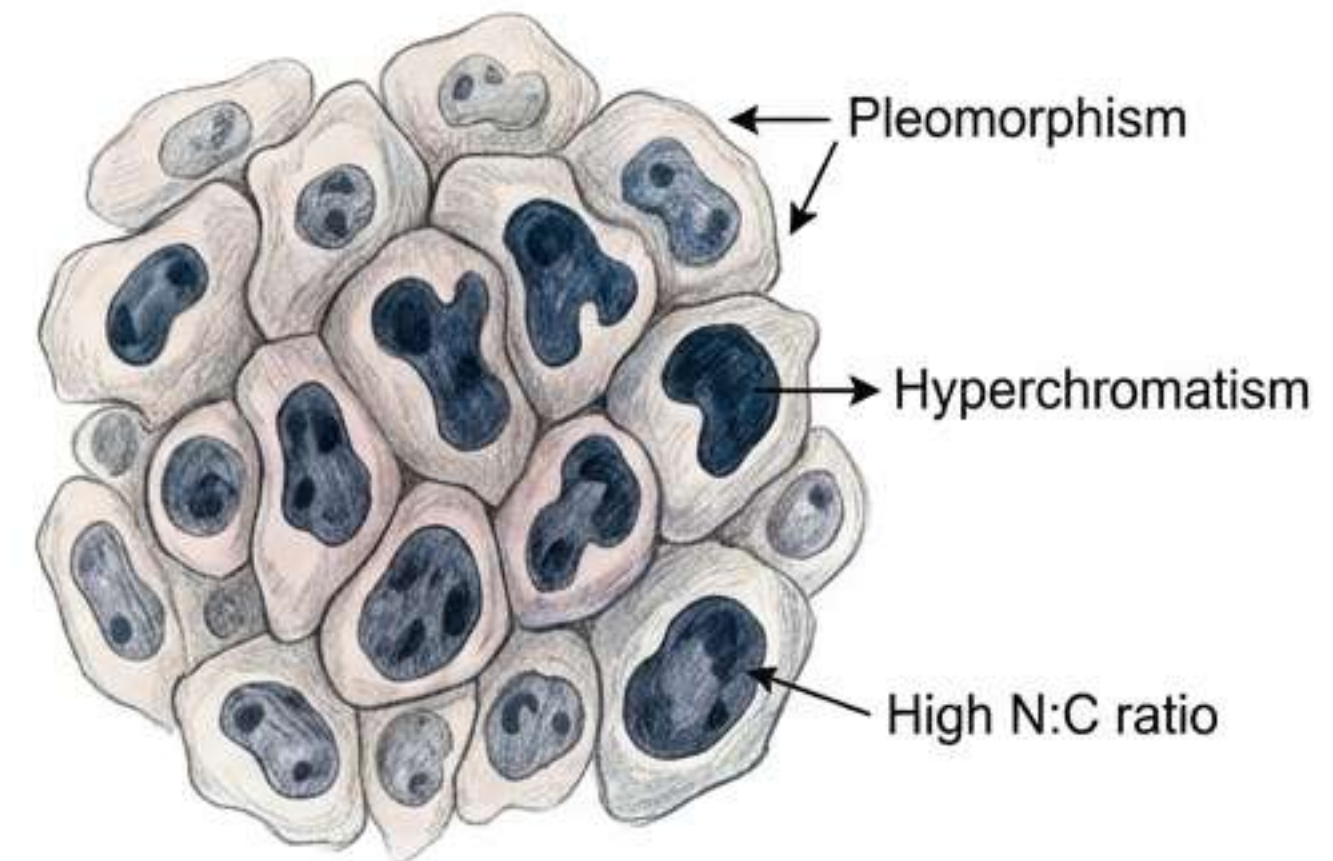
Concerne les tumeurs malignes totalement indifférenciées.

L'absence de différenciation (anaplasie) est un caractère formel de malignité.

La Maturation

- Tumeurs malignes bien différenciées : Différenciation par maturation.
- Tumeurs malignes indifférenciées : Pas de maturation.
- Origine : Cellules de réserve ou cellules souches (tissus épithéliaux).

Anaplasia



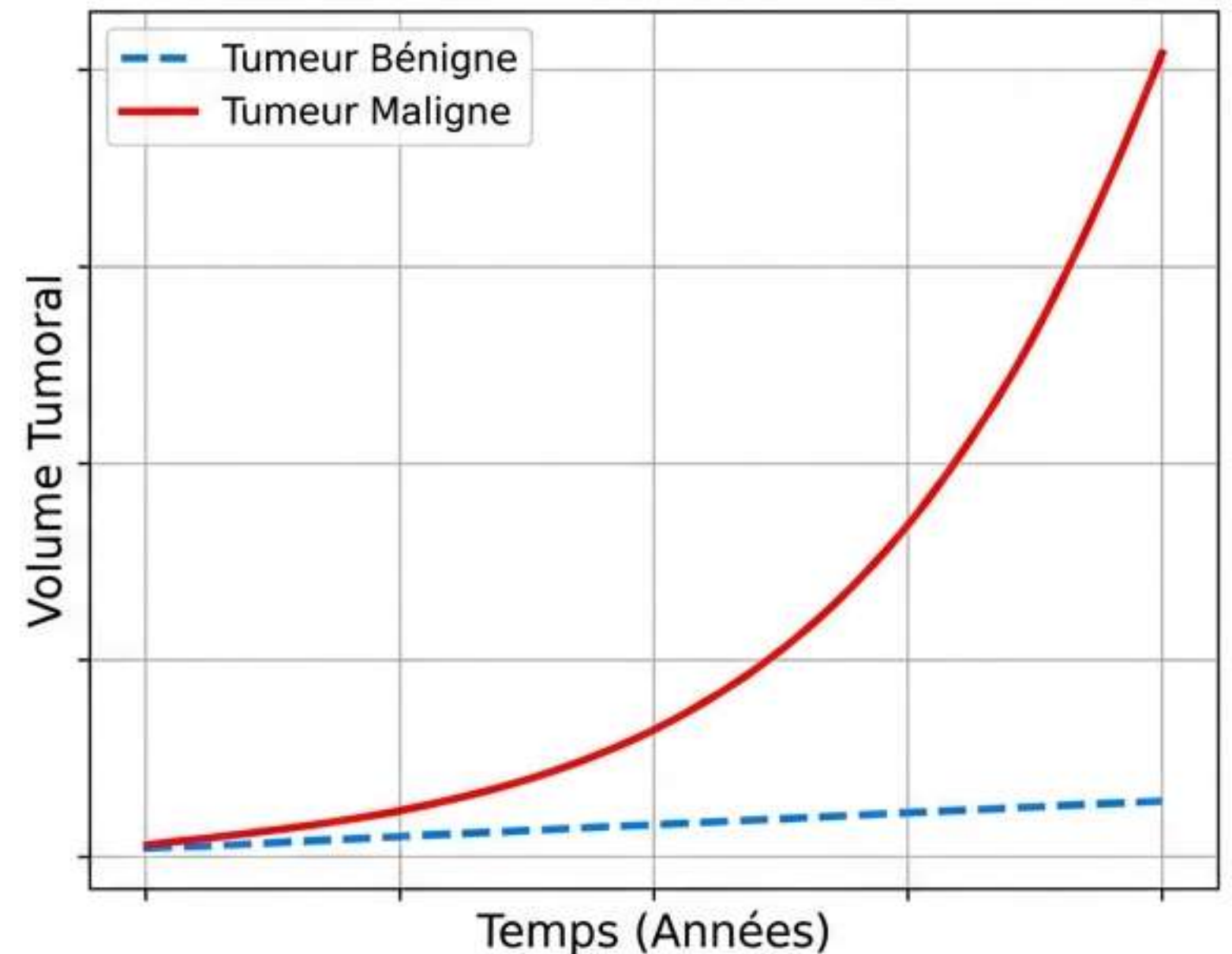
2. Classification : Critère 3 - Taux de Croissance

Tumeurs Bénignes :

- Croissance lente (plusieurs années).
- Nuance : Peut être rapide mais limitée par l'apport sanguin.

Tumeurs Malignes :

- Croissance généralement rapide.
- Corrélation : Plus la tumeur est indifférenciée, plus la croissance est rapide.
- Comportement variable (rémission possible ou décès en quelques mois).

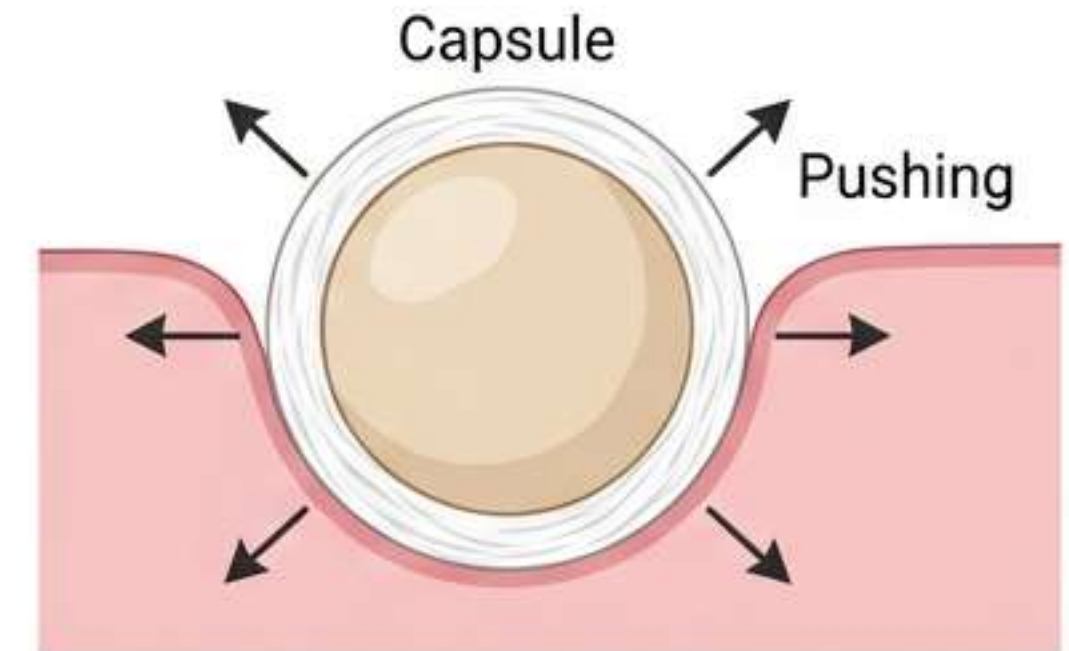


2. Classification : Critère 4 - Envahissement Local

Bénigne

Restent localisées. Refoulement des tissus voisins sans destruction.

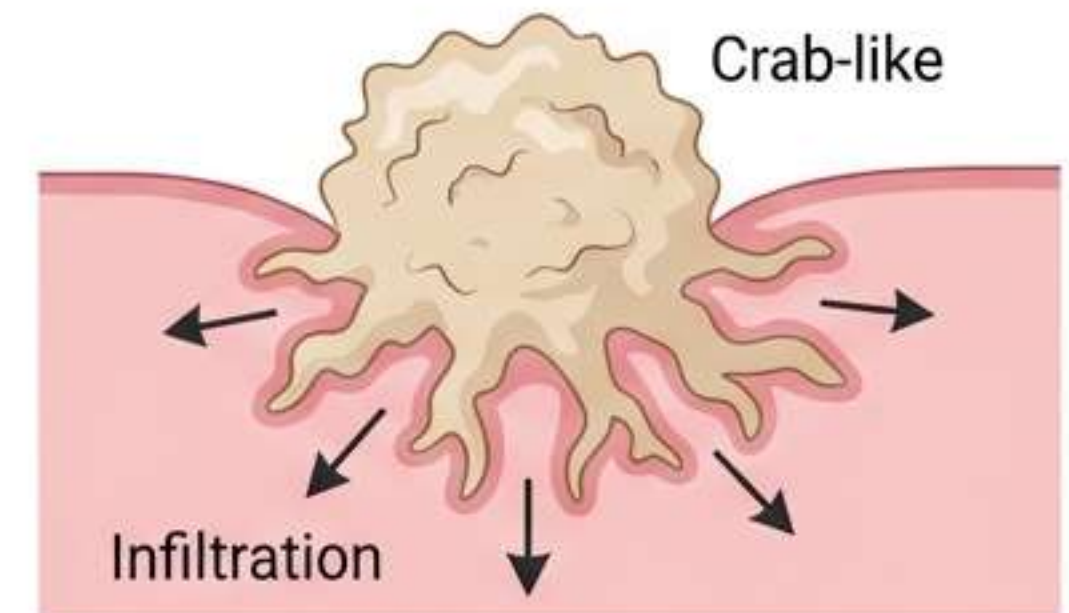
Elles sont bien limitées et souvent encapsulées. [Ref: Q3]



Maligne

Mal limitées et non encapsulées. Destruction des tissus.

Contrairement aux bénignes, les tumeurs malignes envahissent et détruisent les tissus voisins. [Ref: Q4]



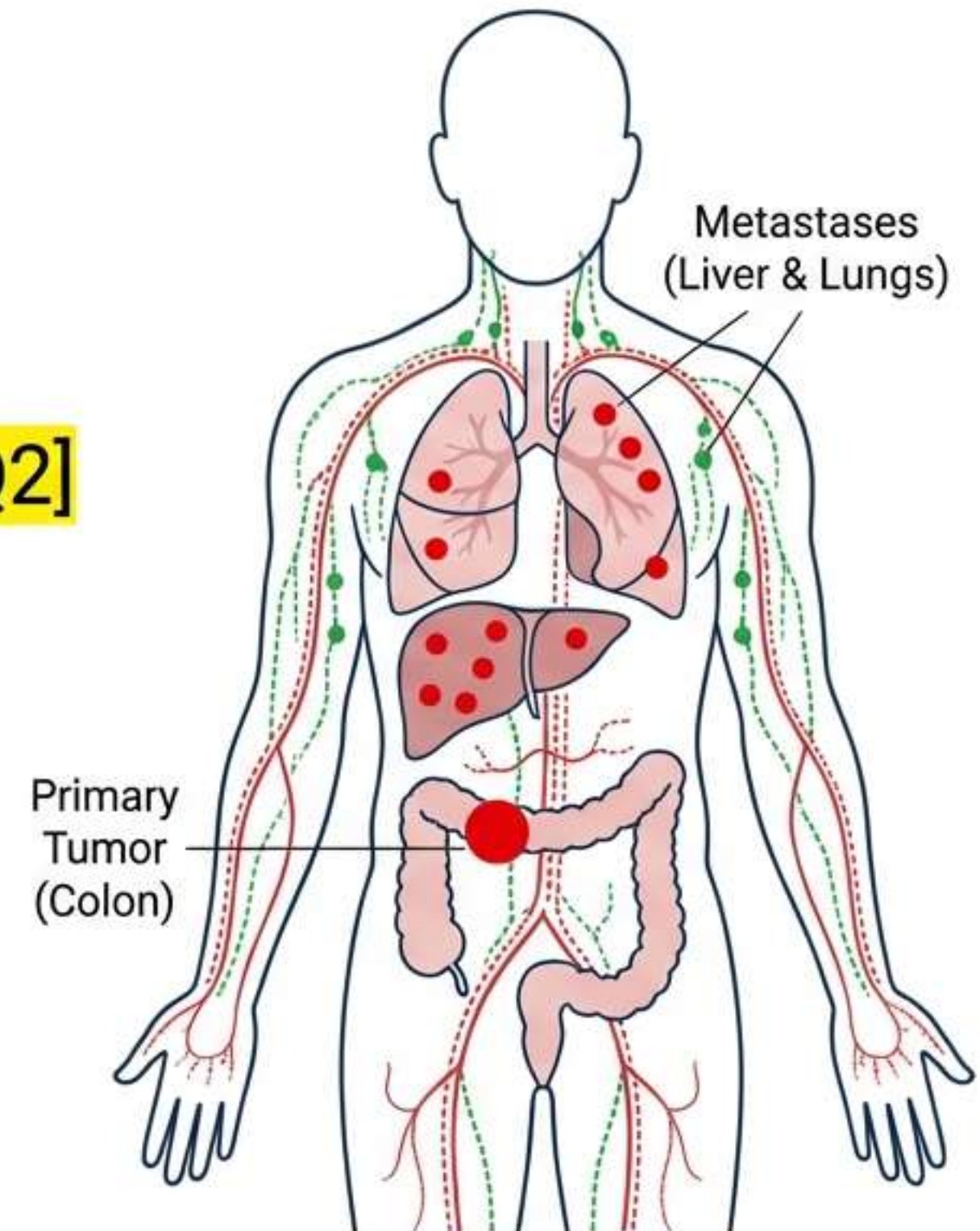
2. Classification : Critère 5 - Métastases

LA RÈGLE ABSOLUE

Les métastases déterminent sans équivoque possible la nature maligne d'une tumeur car les tumeurs bénignes ne métastasent jamais. [Ref: Q2]

La présence de métastase est le critère qui permet d'affirmer la malignité. [Ref: Q9]

Extension à distance de la tumeur (non contiguë).



Synthèse : Tumeurs Bénignes vs Tumeurs Malignes

Caractères	Tumeurs Bénignes	Tumeurs Malignes
Macroscopie	Bien limitée, Encapsulée	Mal limitée, Non encapsulée
Microscopie	Semblable au tissu d'origine. Pas d'anomalies cyto-nucléaires [Ref: Q3]	+/- semblable. Présence d'anomalies cyto-nucléaires [Ref: Q4]
Croissance	Lente	Rapide
Rapport Tissus	Refoulement (Compression)	Envahissement / Destruction
Evolution	Pas de récurrence (si exérèse complète)	Récurrence possible
MÉTASTASE	**JAMAIS**	**POSSIBLE / OUI**

3. Nomenclature : Principes Généraux

Le suffixe “-ome” est généralement utilisé pour les tumeurs.

Le suffixe “-ome” désigne généralement une tumeur bénigne. [Ref : Q11]

Exceptions notables : Lymphome, Mélanome (Malins).

Tissu d'Origine : Épithélial | Conjonctif | Hématopoïétique | Nerveux | Mélanique

3. Nomenclature : Tissu Épithélial

Tissu	Bénin	Malin
Épithélium Malpighien Stratifié 	Papillome malpighien	[HIGHLIGHT] Carcinome épidermoïde [Ref: Q7] [/HIGHLIGHT]
Épithélium Glandulaire 	Adénome	[HIGHLIGHT] Adénocarcinome [Ref: Q8] [/HIGHLIGHT]

Le terme Carcinome désigne une tumeur maligne épithéliale. [Ref: Q5]

3. Nomenclature : Tissu Conjonctif

Le terme 'Sarcome' désigne une tumeur maligne du tissu conjonctif. [Ref : Q12]

Fibroblastes -> Fibrome	→	Fibrosarcome
Tissu adipeux -> Lipome	→	Liposarcome
Musculaire lisse -> Léiomyome	→	Léiomyosarcome
Musculaire strié -> Rhabdomyome	→	Rhabdomyosarcome
Vasculaire -> Angiome	→	Angiosarcome
Cartilagineux -> Chondrome	→	Chondrosarcome
Osseux -> Ostéome	→	Ostéosarcome

3. Nomenclature : Autres Tissus



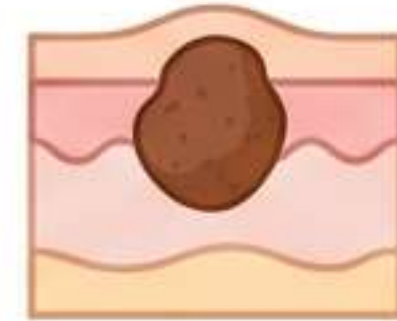
Hématopoïétique

- Tissu Lymphoïde
- Malin : Lymphomes et Maladie de Hodgkin



Nerveux

- Méninge : Méningiome -> Méningiome malin
- Nerf : Schwannome / Neurofibrome -> Schwannome malin



Mélanique

- Bénin : Nævus naevocellulaire
- Malin : Mélanome (Exception : finit par -ome mais toujours malin)

Synthèse Globale (Mind Map)

